

Новости

Наши услуги

О компании

Видаль БОКС

Парафармацевтика

Ветеринария

Калькуляторы

МКБ-11

Внедрение ИИ

Препараты

Медицинская энциклопедия

Специалистам

Поиск аналогов

[Видаль](#) [Описания препаратов](#) [Активные вещества](#)
ЭПОЭТИН АЛЬФА

ЭПОЭТИН АЛЬФА (EPOETIN ALFA) ОПИСАНИЕ

Rec.INN зарегистрированное ВОЗ

Лекарственное взаимодействие

Фармакологическое действие

Показания препарата

Побочное действие

Особые указания

Фармакокинетика

Режим дозирования

Противопоказания к применению

Лекарственное взаимодействие

Вход для
специалистов

Логин/e-mail:

Пароль:

Войти

Регистрация

Забыли пароль?



Входит в состав препаратов

Фармакологическое действие

Гликопротеид, специфически стимулирующий эритропоэз, активирует митоз и созревание эритроцитов из клеток-предшественников эритроцитарного ряда. Рекомбинантный эпоэтин альфа синтезируется в клетках млекопитающих, в которые встроен ген, кодирующий человеческий эритропоэтин. По своему составу, биологическим и иммунологическим свойствам эпоэтин альфа идентичен природному эритропоэтину человека. Введение эпоэтина альфа приводит к повышению гемоглобина и гематокрита, улучшению кровоснабжения тканей и работы сердца. Наиболее выраженный эффект от применения эпоэтина альфа наблюдается при анемиях, обусловленных хронической почечной недостаточностью. В очень редких случаях, при длительном применении эритропоэтина для терапии анемических состояний, может наблюдаться образование нейтрализующих антител к эритропоэтину с развитием парциальной красноклеточной аплазии или без нее.

Фармакокинетика

При в/в введении эпоэтина альфа у здоровых лиц и пациентов с уреимией $T_{1/2}$ составляет 5-6 ч. При п/к введении эпоэтина альфа его концентрация в крови нарастает медленно и C_{max} в период от 12 до 18 ч после введения, $T_{1/2}$ составляет 16-24 ч. Биодоступность эпоэтина альфа при п/к введении составляет 25-40%.

Показания активного вещества ЭПОЭТИН АЛЬФА

Анемия, связанная с хронической почечной недостаточностью у взрослых, находящихся на гемодиализе или перитонеальном диализе, а также тяжелая анемия почечного происхождения, сопровождающаяся клиническими симптомами у взрослых пациентов с почечной недостаточностью, еще не

Анемия, связанная с хронической почечной недостаточностью у детей, находящихся на гемодиализе или перитонеальном диализе.

Анемия у взрослых онкологических пациентов при солидных (немиелоидных) опухолях, злокачественной лимфоме или множественной миеломе, получающих химиотерапию (для лечения анемии и снижения потребности в трансфузиях).

Анемия у взрослых ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих терапию зидовудином, при концентрации эндогенного эритропоэтина менее 500 МЕ/мл.

В рамках предепозитной программы перед обширным хирургическим вмешательством у взрослых пациентов с гематокритом, равным 33-39 %, для облегчения сбора аутологичной крови и уменьшения риска, связанного с использованием аллогенных гемотрансфузий, если ожидаемая потребность в переливаемой крови превышает количество, которое можно получить методом аутологичного сбора без применения эпоэтина альфа.

Перед проведением обширной операции с ожидаемой средней кровопотерей (2-4 единицы или 900-1800 мл) у взрослых пациентов с легкой или средней анемией (гемоглобин >10 и ≤13 г/дл) для уменьшения потребности в аллогенных гемотрансфузиях и улучшения восстановления эритропоэза.

[Открыть список кодов МКБ](#)

Реклама. ООО "ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА", ИНН 9710085580

Режим дозирования

Вводят п/к или в/в. Режим дозирования устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, наличия сопутствующих заболеваний, схемы терапии, возраста пациента.

Реклама

Побочное действие

Со стороны системы кроветворения: очень редко - эритропоэтиновая антителоопосредованная парциальная красноклеточная аплазия, тромбоцитемия.

Со стороны иммунной системы: нечасто - реакции повышенной чувствительности; редко - анафилактические реакции.

Со стороны обмена веществ: нечасто - гиперкалиемия; частота неизвестна - порфирия.

Со стороны нервной системы: часто - головная боль, судороги, частота не установлена - цереброваскулярные осложнения (в т.ч. инсульт, включающий церебральный инфаркт и внутримозговое кровоизлияние), транзиторная ишемическая атака, гипертоническая энцефалопатия.

Со стороны органа зрения: частота неизвестна - тромбоз сосудов сетчатки.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто - артериальная гипертензия (в т.ч. гипертонический криз), артериальные и венозные (в т.ч. летальные случаи) тромбозы и эмболии: тромбоз глубоких вен, артериальный тромбоз (в т.ч. инфаркт миокарда), тромбоз артериовенозного шунта аневризмы, эмболия легочной артерии.

Со стороны дыхательной системы: часто - кашель; частота неизвестна - застойные явления в дыхательных путях.

Со стороны пищеварительной системы: очень часто - диарея, тошнота, рвота.

Со стороны кожи и подкожных тканей: часто - кожная сыпь; частота неизвестна - крапивница, ангионевротический отек, многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.

Со стороны костно-мышечной системы: часто - артралгия, миалгия, боль в костях, боль в конечностях.

Прочие: очень часто - повышение температуры тела; часто - озноб, гриппоподобный синдром, периферические отеки, местные реакции.

Противопоказания к применению

Повышенная чувствительность к эпоэтину альфа; неконтролируемая артериальная гипертензия; пациенты с тяжелой патологией коронарных, сонных, мозговых и периферических сосудов, включая недавно перенесших инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения (в рамках преддепозитной программы сбора крови перед обширной хирургической операцией); пациенты с парциальной красноклеточной аплазией, получавшим терапию каким-либо эритропоэтином; пациенты, которые по каким-либо причинам не получающие адекватную профилактическую антитромботическую терапию; беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

Пациенты с эпилепсией, эпилептическим синдромом (в т.ч. в анамнезе) или с заболеваниями, которые могут спровоцировать эпилептическую активность (например, инфекции ЦНС или метастазы мозга), тромбоцитозом, тромбозом (в анамнезе), облитерирующими заболеваниями периферических сосудов и другими сосудистыми осложнениями, подагрой, при серповидно-клеточной анемии, при дефиците железа, витамина B₁₂ или фолиевой кислоты; при ИБС, парциальной красноклеточной аплазии, злокачественных новообразованиях костного мозга, у пациентов с порфирией.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение эпоэтина альфа при беременности и в период грудного вскармливания.

У некоторых пациенток с хронической почечной недостаточностью на фоне лечения эпоэтином альфа отмечалось возобновление менструаций. Возможность наступления беременности и необходимость контрацептивных мер должны быть обсуждены с пациенткой до начала терапии.

Применение при нарушениях функции печени

Эпоэтин альфа также следует с осторожностью применять у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Безопасность эпоэтина альфа у

метаболизма у пациентов с нарушением функции печени при применении эпоэтина альфа может происходить усиление эритропоэза.

Применение при нарушениях функции почек

У пациентов с хронической почечной недостаточностью и клинически выраженной ИБС или застойной сердечной недостаточностью поддерживающий уровень гемоглобина не должен превышать верхний предел оптимального рекомендованного уровня (не более 10-12 г/дл у взрослых).

Применение у детей

Возможно применение у детей по показаниям, в рекомендуемых дозах и схемах.

Особые указания

До и после начала терапии эпоэтином альфа необходимо адекватно контролировать АД. Во время терапии эпоэтином альфа может понадобиться назначение гипотензивной терапии. При невозможности снизить АД гипотензивными средствами терапию эпоэтином альфа необходимо прекратить.

Гипертонический криз, сопровождаемый энцефалопатией и судорогами, требующий немедленного медицинского вмешательства, также может произойти во время терапии эпоэтином альфа у пациентов, ранее имевших нормальное или пониженное АД. Особое внимание следует уделять внезапно возникшей стреляющей мигреноподобной головной боли как возможному сигналу наступления криза.

У пациентов, получавших лечение эпоэтином, отмечалась антителоопосредованная истинная эритроцитарная аплазия (ИЭА). Изредка отмечались также случаи этого заболевания у пациентов с гепатитом С, получавших лечение интерфероном и рибавирином, когда одновременно проводилось лечение эритропоэтин-стимулирующими препаратами, поэтому они не одобрены для лечения анемии, связанной с гепатитом С.

У пациентов с хронической почечной недостаточностью, у которых возникает внезапное снижение эффективности, определяемое по снижению гемоглобина (10-20 г/л в месяц) с повышением потребности в трансфузиях, необходимо провести подсчет количества ретикулоцитов и обследование на наличие типичных причин отсутствия ответа (например, дефицит железа, фолиевой кислоты или витамина В12, интоксикация алюминием, инфекция или воспаление, кровопотеря, гемолиз и фиброз костного мозга любого генеза). Если количество ретикулоцитов, скорректированное с учетом анемии (т.е. ретикулоцитарный "индекс") низкое (< 20000/мкл или < 0.5%), а количество тромбоцитов и лейкоцитов нормально, и если не выявлены другие причины снижения эффекта, следует провести определение концентрации антител к эритропоэтину, а также рассмотреть возможность исследования костного мозга с целью диагностики ИЭА.

Если возникает подозрение на ИЭА, опосредованную антиэритропоэтиновыми антителами, терапию эпоэтином альфа следует немедленно прекратить. Не следует начинать лечение какими-либо иными эритропоэтин-стимулирующими препаратами, поскольку существует риск перекрестной реакции. При наличии показаний пациентам может быть проведена соответствующая терапия, такая как переливание крови.

Эпоэтин альфа необходимо применять с осторожностью у пациентов с эпилепсией, эпилептическими припадками в анамнезе и заболеваниями, ассоциирующимися с эпилептическими припадками (например, инфекциями ЦНС и метастазами в головном мозге).

Эпоэтин альфа также следует с осторожностью применять у пациентов с хронической печеночной недостаточностью. Безопасность эпоэтина альфа у пациентов с нарушением функции печени не установлена. Вследствие сниженного метаболизма у пациентов с нарушением функции печени при применении эпоэтина альфа может происходить усиление эритропоэза.

Следует тщательно сопоставлять риск тромботических сосудистых осложнений и пользу от лечения эпоэтином альфа, в особенности у пациентов с наличием факторов риска.

У всех пациентов следует проводить тщательный мониторинг уровня гемоглобина из-за потенциально повышенного риска тромбоэмболических явлений и

Безопасность и эффективность терапии эпоэтином альфа у пациентов с фоновыми гематологическими заболеваниями, например, такими как, гемолитическая анемия, серповидно-клеточная анемия, талассемия изучена не была.

При лечении эпоэтином альфа требуется регулярный контроль уровня тромбоцитов, особенно в течение первых 8 недель, т.к. возможно развитие дозозависимого относительного повышения количества тромбоцитов, которое нормализуется в дальнейшем без отмены терапии; в редких случаях отмечается абсолютное повышение числа тромбоцитов

Перед началом терапии эпоэтином альфа, а также при принятии решения о повышении его дозы следует провести оценку и лечение других причин анемии (дефицит железа, фолиевой кислоты или витамина B12, интоксикация алюминием, инфекция или воспаление, кровопотеря, гемолиз и фиброз костного мозга любого генеза). В большинстве случаев значения концентрации ферритина в сыворотке крови снижаются одновременно с увеличением гематокрита. Для достижения оптимального ответа на эпоэтин альфа следует обеспечить адекватные запасы железа с введением, при необходимости, дополнительного приема препаратов железа, в зависимости от показаний.

Средства, стимулирующие эритропоэз, не обязательно эквивалентны. Поэтому необходимо уточнить, что пациентов следует переводить с одного препарата, стимулирующего эритропоэз, на другой только с одобрения лечащего врача.

Эпоэтин альфа обладает минимальной способностью индуцировать образование антител. Исследований канцерогенности не проводилось.

Эпоэтин альфа, будучи ростовым фактором, может оказывать стимулирующее действие на некоторые типы опухолей, особенно на злокачественные новообразования костного мозга.

Пациентам с хронической почечной недостаточностью на фоне лечения эпоэтином альфа необходимо регулярно измерять уровень гемоглобина до тех пор, пока он не достигнет стабильных значений, с периодическим контролем в дальнейшем.

Для уменьшения риска возникновения артериальной гипертензии скорость повышения уровня гемоглобина должна составлять приблизительно 10 г/л (максимально 20 г/л) в месяц. Доза должна быть уменьшена в случае, если уровень гемоглобина достигнет 120 г/л.

У пациентов с хронической почечной недостаточностью поддерживаемый уровень гемоглобина не должен превышать верхней границы. Уровень гемоглобина 130 г/л и выше может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений, включая смерть.

Пациенты с хронической почечной недостаточностью и недостаточным ответом гемоглобина на терапию эритропоэтин-стимулирующими препаратами могут подвергаться даже еще большему риску сердечно-сосудистых осложнений и смертности, чем другие пациенты.

У пациентов на гемодиализе возникали тромбозы шунтов, в особенности, у пациентов с тенденцией к гипотензии или с осложнениями со стороны артериовенозных фистул (например, стенозы, аневризмы и т.д.). У данных пациентов рекомендуются ранняя проверка шунта и профилактика тромбоза путем введения, например, ацетилсалициловой кислоты.

В отдельных случаях наблюдалась гиперкалиемия, хотя ее причинно-следственная связь с применением препарата не установлена. У пациентов с хронической почечной недостаточностью следует проводить мониторинг электролитов сыворотки. Если уровень калия в сыворотке повышен или нарастает, тогда, в дополнение к надлежащему лечению гиперкалиемии, следует рассмотреть возможность прекращения введения эпоэтина альфа вплоть до корректировки уровня содержания калия в сыворотке.

Вследствие повышения гематокрита на фоне терапии эпоэтином альфа пациентам на гемодиализе может потребоваться увеличение дозы гепарина, в противном случае возможна окклюзия диализной системы.

Анемия у взрослых онкологических пациентов при солидных (немиелоидных) опухолях, злокачественной лимфоме или множественной миеломе, получающих химиотерапию (для лечения анемии и снижения потребности в трансфузиях)

Средства, стимулирующие эритропоэз, являются факторами роста, которые стимулируют, в первую очередь, образование эритроцитов. Рецепторы

опухолей. Таким образом, решение о введении препарата рекомбинантного эритропоэтина должно приниматься на основании оценки отношения риска и пользы с участием конкретного пациента и должно учитывать конкретную клиническую ситуацию. Факторы, которые следует рассматривать при такой оценке, включают: тип и стадию опухоли; степень тяжести анемии; ожидаемую продолжительность жизни; условия, в которых пациент получает лечение; предпочтения пациента.

В клинических исследованиях при применении препаратов рекомбинантного эритропоэтина в комбинации с другими средствами, стимулирующими эритропоэз, было отмечено:

- ухудшение локорегионарного контроля у пациентов с распространенными злокачественными новообразованиями головы и шеи, получающих лучевую терапию, в случае применения данных препаратов для достижения концентрации гемоглобина более 140 г/л;
- снижение общей выживаемости и увеличение смертности, связанной с прогрессированием заболевания, через 4 месяца приема пациентами с метастатическим раком молочной железы, получающих химиотерапию, в случае применения данных препаратов для достижения концентрации гемоглобина от 120 до 140 г/л;
- увеличение смертности при приеме других средств, стимулирующих эритропоэз (дарбэпоэтин альфа), для достижения концентрации гемоглобина 120 г/л у пациентов с активными злокачественными новообразованиями, не получающими ни химиотерапию, ни лучевую терапию. Средства, стимулирующие эритропоэз, не показаны к применению у данной группы пациентов.

У пациентов с онкологическим заболеванием, получающих химиотерапию, при оценке пригодности терапии эпоэтином альфа (в особенности у пациентов, подверженных риску трансфузии) следует учитывать задержку в 2-3 недели между введением средств, стимулирующих эритропоэз и появлением стимулированных эритропоэтином эритроцитов.

Если ВИЧ-инфицированный пациент не отвечает или ответ на терапию эпоэтином альфа недостаточный, следует рассмотреть другие возможные причины анемии, включая дефицит железа.

У пациентов, связанных с программой сбора аутологичной крови и получающих дополнительное лечение эпоэтином альфа, следует учитывать все особые предупреждения и особые меры предосторожности, в особенности - обязательное восполнение объема.

Перед проведением обширной операции с ожидаемой кровопотерей в до- и послеоперационном периоде всегда следует соблюдать надлежащие стандарты контроля показателей крови.

Пациентам, которым назначена большая плановая ортопедическая операция, следует проводить антитромботическую профилактику, поскольку у хирургических пациентов могут возникать тромботические и сосудистые осложнения, в особенности у пациентов с фоновым сердечно-сосудистым заболеванием. Кроме того, следует соблюдать особые меры предосторожности у пациентов с предрасположенностью к развитию тромботических осложнений. Более того, у пациентов с исходным уровнем гемоглобина > 130 г/л нельзя исключить возможности того, что лечение эпоэтином альфа может быть связано с повышенным риском послеоперационных тромботических сосудистых осложнений. Следовательно, у пациентов с исходным уровнем гемоглобина >130 г/л применение эпоэтина альфа не рекомендуется.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

В период лечения до установления оптимальной поддерживающей дозы пациентам с уремией следует избегать занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций из-за увеличения риска повышения АД в начале терапии.

Лекарственное взаимодействие

Действие эпоэтина альфа может усиливаться при одновременном введении препаратов крови.

Одновременное применение препаратов, подавляющих эритропоэз, может приводить к снижению эффективности эпоэтина альфа.

контроль уровня циклоспорина в сыворотке крови с последующей коррекцией.
Стимулирующее действие эпоэтина альфа на эритропоэз может усиливаться при одновременном приеме препаратов железа в случае дефицита железа.
При одновременном проведении противосудорожной терапии может повыситься склонность к судорогам.
При совместном применении с гипотензивными препаратами возможно ослабление их действия. Имеются данные о влиянии ингибиторов АПФ на действие препаратов эпоэтина альфа при совместном применении.
Эпоэтин альфа нельзя смешивать с растворами других лекарственных средств.

Список использованной литературы

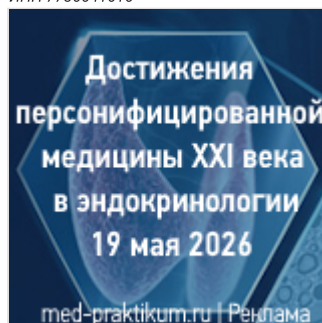
1. "Государственный Реестр лекарственных средств",
<http://www.grls.rosminzdrav.ru;>
2. Goodman & Gilman's "The Pharmacological Basis of Therapeutics", 14th Edition, 2022;
3. Д.А. Харкевич "Фармакология", 13-е издание, 2022;
4. MARTINDALE The Complete Drug Reference, 41st Edition, 2024;
5. "Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система)", Выпуск XVIII – М.: "Видокс", 2017;
6. "Национальные руководства: серия практических руководств по основным медицинским специальностям", Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2025.

Проверено врачом-экспертом

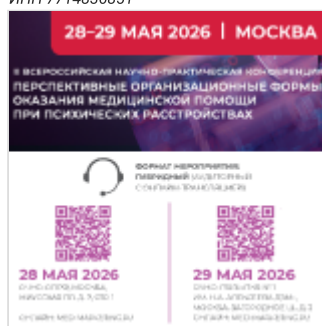


Толмачева Екатерина Александровна
кандидат медицинских наук, стаж 45 лет

Реклама. ООО "ИИСИ Медикал",
ИНН 7736641616



Реклама. ООО «Интегрити»,
ИНН 7714836851



Реклама. АО "Видаль Рус", ИНН 7728043605





Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов. Информация, содержащаяся на сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-79153 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15 сентября 2020 года.

[Пользовательское соглашение](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Политика обработки файлов cookie](#)

Copyright © Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России»



[Контакты](#) [Редакция](#) [Карта сайта](#) [Лицензии](#) [Размещение рекламы](#) [Разработка сайта](#)